

Burnout

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es el burnout?

El burnout (síndrome de agotamiento) es un estado de agotamiento físico, emocional y mental crónico, resultado de una exposición prolongada a demandas laborales o cuidadoras que superan los recursos disponibles. La OMS lo reconoce como un fenómeno ocupacional con impacto clínico significativo.

No es debilidad ni falta de compromiso. Es la consecuencia de un desequilibrio sostenido entre exigencias y recursos, frecuentemente en personas con alto nivel de implicación y responsabilidad.

Tres dimensiones centrales (Maslach):

- Agotamiento: sensación de vaciamiento de los recursos emocionales y físicos
- Despersonalización / cinismo: distanciamiento emocional del trabajo, las personas o las responsabilidades
- Reducción de la eficacia: sensación de incompetencia y pérdida del sentido de logro

02. Diferencia entre estrés, agotamiento y burnout

Dimensión	Estrés · Agotamiento · Burnout
Duración	Agudo o crónico · Temporal · Crónico e instalado
Estado emocional	Hiperactivación · Cansancio · Vaciamiento y desconexión
Motivación	Presente · Reducida · Muy baja o ausente
Recuperación	Con descanso · Con descanso prolongado · Requiere intervención activa
Relación con el trabajo	Sigue comprometido · Nota sobrecarga · Desconexión o cinismo marcados

03. Presentación clínica

Síntomas emocionales:

- Vaciamiento emocional: sensación de no tener nada más para dar
- Distanciamiento afectivo de las personas, el trabajo o las responsabilidades
- Irritabilidad, impaciencia o explosiones emocionales
- Sensación de fracaso, inutilidad o pérdida del sentido
- Tristeza, desmotivación o apatía generalizada

Síntomas cognitivos:

- Dificultad de concentración y memoria
- Incapacidad para tomar decisiones o priorizar
- Pensamiento rígido o reducido en creatividad
- Cinismo o actitud negativa generalizada hacia el trabajo

Síntomas físicos:

- Fatiga que no se recupera con el descanso
- Alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia)
- Síntomas somáticos: cefaleas, problemas digestivos, infecciones frecuentes
- Disminución de la respuesta inmune

04. Factores de riesgo

Factores del contexto	Factores individuales
Sobrecarga de trabajo crónica	Perfeccionismo y autoexigencia elevada
Falta de autonomía o control sobre las tareas	Dificultad para establecer límites
Ausencia de reconocimiento o retroalimentación	Necesidad de aprobación o alta orientación al deber
Conflictos de rol o valores	Dificultad para delegar o pedir ayuda
Entorno laboral con alta demanda emocional	Tendencia a priorizar el trabajo sobre el autocuidado
Falta de apoyo social o aislamiento	Historia de rasgos ansiosos o depresivos

05. El ciclo del burnout

- Alta implicación inicial: entusiasmo, compromiso intenso, dificultad para desconectarse
- Acumulación de demandas sin recuperación suficiente
- Primeras señales de agotamiento, ignoradas o minimizadas
- Reducción del rendimiento que genera más esfuerzo compensatorio
- Desconexión emocional como mecanismo de protección
- Instalación del vaciamiento: ya no hay recursos para recargar

Clave clínica: El burnout suele afectar a personas muy comprometidas con su trabajo. El cinismo y la desconexión son respuestas adaptativas tardías al agotamiento, no rasgos de carácter.

06. Abordaje clínico

Intervenciones prioritarias:

- Validación y psicoeducación: nombrar el cuadro y diferenciarlo de la depresión
- Evaluación de factores modificables en el entorno laboral
- Trabajo con límites: identificar patrones de sobreimplicación y construir límites sostenibles
- Recuperación del autocuidado básico: sueño, alimentación, movimiento, desconexión
- Reestructuración de creencias sobre el deber, el rendimiento y el valor propio
- Reconexión con valores y fuentes de sentido más allá del trabajo
- Evaluación de comorbilidades: el burnout frecuentemente coexiste con depresión y ansiedad

Nota clínica: Si el burnout es grave, puede ser necesario un período de baja laboral antes de iniciar trabajo psicológico de mayor profundidad. La estabilización es el primer objetivo.